

CEFALEIA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

TENSIONAL

- **Ainda na UPA/PS (Uso oral):**

Dipirona/paracetamol 500 mg ---- 2 cp

Tomar 02 comprimidos por via oral agora.

Ibuprofeno 600 mg ---- 1 comprimido

Tomar 01 comprimido por via oral agora.

- **Ainda na UPA/PS (Uso EV):**

Dipirona 500 mg/ml ---- 1 ampola de 2 ml

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 10 ml de SF 0,9% e infundir EV “lento” (1 a 2 minutos).

Cetoprofeno 100 mg/100 ml ---- 1 bolsa com 100 mL

Infundir em 20 minutos EV agora.

(Caso seja o frasco/ampola, diluir 100 mg em 100 a 150 mL de SF 0,9% ou SG 5% e infundir em 20 minutos).



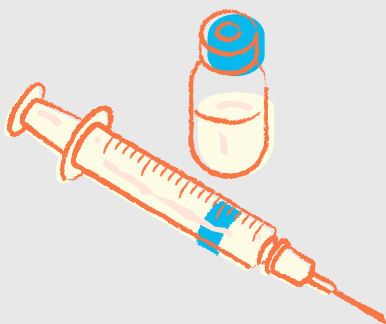
TENSIONAL

- **Ainda na UPA/PS (Uso IM):**

Diclofenaco Sódico 25 mg/ml ---- 1 Frasco-Ampola (3 ml)

Administrar 1 ampola via Intramuscular (dose total de 75 mg) agora.

Pode-se também utilizar Dipirona por esta via.



ROTINA CLÍNICA

TENSIONAL

- **Para casa:**

Dipirona 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar de 1 a 2 comprimidos de 6/6h em caso de dor e/ou febre.

(Pode utilizar paracetamol no lugar da dipirona, mantendo a mesma dose e posologia).

Ibuprofeno 600 mg ---- 15 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de dor forte e refratária à dipirona/paracetamol (fazer uso por no máximo 5 dias).



ENXAQUECA

- **Ainda na UPA/PS (Uso EV):**

Dipirona 500 mg/ml ---- 1 Ampola (2 ml)

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 10 ml de SF 0,9% e infundir EV “lento” (1 a 2 minutos)

Cloridrato de Metoclopramida 5 mg/ml ---- 1 Frasco-Ampola (2 ml)

Diluir o conteúdo de 1 ampola em 10 ml de SF 0,9% e infundir EV em, no mínimo, 3 minutos.
(risco de reação extrapiramidal)

- **Opção oral (se disponível):**

Sumatriptano 50 mg ---- 1 comprimido

Tomar 1 comprimido VO agora.



ROTINA CLÍNICA

ENXAQUECA

- **Ainda na UPA/PS (Uso IM):**

Diclofenaco Sódico 25 mg/ml ---- 1 Frasco-Ampola (3 ml)

Administrar 1 ampola via intramuscular (dose total de 75 mg) agora.

Dexametasona 4 mg/2,5 ml ---- 1 Ampola (2,5 ml)

Administrar 1 ampola via intramuscular agora.

- **Ainda na UPA/PS (Uso SC):**

Sumatriptano 6 mg --- 1 ampola

Administrar 1 ampola via SC agora.

Detalhe: o intervalo entre as doses deve ser de, no mínimo, uma hora. A dose máxima recomendada que pode ser utilizada em 24 horas é de 12 mg (2 ampolas).



ENXAQUECA

- **Para casa:**

Sumatriptano 50 mg ---- 1 caixa

Tomar 1 comprimido caso dor forte e refratária aos analgésicos comuns.

Em caso de dor intensa, tomar 1 comprimido de 6/6h.

Ondansetrona 4 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de náuseas e/ou vômitos.

Utilizar também: analgésicos simples (Dipirona e Paracetamol) e AINES (com cautela).

Orientar o paciente sobre a maior efetividade da analgesia quando utilizada no início da crise.



SALVAS

- **Ainda na UPA/PS (1ª linha):**

Oxigênio a 100% com fluxo de 10 a 12 litros por minuto em máscara não-reinalante por 10 a 20 minutos

Sumatriptano 6 mg via subcutânea, ou 20 mg spray nasal (a formulação oral tem menor efetividade nestes casos).

(Caso não tenha disponibilidade de prescrever o Sumatriptano, realizar analgesia parenteral otimizada conforme medicações disponíveis no seu serviço!)



SALVAS

- **Para casa:**

Cloridrato de Verapamil 80 mg ---- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h. (240 a 480 mg/dia)

Ou

Topiramato 25 mg ---- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido à noite.

É fundamental encaminhar o paciente para seguimento ambulatorial com neurologista e orientar sobre fatores desencadeantes (bebidas alcoólicas, tabagismo, substâncias voláteis com odor intenso).



ROTINA CLÍNICA

ORIENTAÇÕES

- **Para todas as cefaleias primárias:**

Orientar sobre fatores desencadeantes, fatores de melhora ou piora e orientar a confecção de diário da cefaleia.

Orientar seguimento ambulatorial em UBS.

Orientar sobre sinais de alarme:

Piora progressiva.

Mudança no padrão da dor e na intensidade.

Sintomas sistêmicos associados (febre, hiporexia).

Alteração neurológica.

Convulsão.

Cefaleia associada a traumatismo craniano.

Caso haja sinais de alarme ou piora, orientar o paciente a procurar atendimento médico imediatamente.

